العلاج المعرفي السلوكي للأكتئاب

ا/عمرو خاطر

اخصائي نفسي

مقدمة:

يعد اضطراب الاكتئاب الرئيسى من الاضطرابات النوابية الخطيرة التى تسبب خلل فى المزاج والسلوك وعمليات التفكير والصحة البدنية.

وعندما لا يتم علاج الاكتئاب بطريقة جيدة قد تتطور شدة الاكتئاب الى الدرجة الشديدة، وبالتالى قد يؤدى الى الانتحار، حيث يقدر بحوالى 50% من المرضى يقومون بمحاولة انتحار على الاقل أثناء حياتهم، ورغم ذلك فإن تقديم العلاج الفعال والذى قد يتضمن العلاج الدوائى والعلاج المعرفى السلوكى يساعد بصوره كبيرة على التحسن.

والمشكلة المهمة لدى مرضى الاكتئاب هى أن المرضى احيانًا لا يدركون أن الاكتئاب هو اضطراب نفسى، ويعزونه إلى ضعف الشخصية او ضعف الإيمان، وبالتالى يرفضون الاستعانه بالعلاجات الفعالة، ويتم علاج معظم المرضى خارج المستشفيات وبعضهم يتطلب مدة قصيرة داخل المستشفى.

ويبلغ انتشار اضطراب الاكتئاب الرئيسى 16% فى الولايات المتحده كل 6 شهور، وينتشر فى الاناث ضعف انتشاره لدى الذكور (عكس الاضطراب ثنائى القطب والذى يتساوى فيه نسب انتشاره بين الذكور والاناث)، ويبدأ اضطراب الاكتئاب الرئيسى فى اى عمر حتى فى الطفولة والمراهقة، ولكن توجد فترتين عمريتين يزداد بداية المرض فيهما، وهى فتره العشرينات والخمسينات من العمر.

ويتصاحب اضطراب الاكتئاب الرئيسى مع اضطرابات أخرى، مثل اضطرابات القلق والتى تصل لـ 85%، كما أن اعراض القلق تنتشر أيضًا اثناء الاكتئاب بنسبة تصل الى 80%.

تشخيص اضطراب الاكتئاب الرئيسى وفقًا للدليل الاحصائى والتشخيصى الخامس للاضطرابات النفسيه DSM-5:

(أ) وجود 5 أعراض (أو أكثر) مما سيرد ذكره، وتكون موجودة لمده اسبوعين، مع ظهور تغير فى الوظائف، بالاضافة الى وجود إما مزاج مكتئب، أو فقدان الاهتمام او المتعة.

1- مزاج اكتئابى معظم اليوم، تقريبًا بصورة يومية، والذى يتم الكشف عنه إما من خلال التقرير الذاتى مثل: (الاحساس بالحزن، أو الفراغ ، أو اليأس) ، أو من خلال الملاحظة بواسطة الاخرين مثل: البكاء.

ملحوظة
يمكن أن يظهر فى الاطفال والمراهقين مزاج غير مستقر irritable mood

2- تناقص الاهتمام أو تناقص الاحساس بالمتعة، فى كل انشطة اليوم أو معظمها، كل يوم تقريبًا (والذى يتم التعبير عنها إما من خلال التقرير الذاتى أو الملاحظة).

3- نقص الوزن بصورة ملحوظة، ولا يكون راجع الى نظام غذائى أو إلى اكتساب الوزن (مثل: تغير أكثر من 5 كجم من وزن الجسم خلال شهر) ، أو قلة أو زيادة الشهية تقريبًا كل يوم.

ملحوظة
فى الاطفال نأخذ فى الاعتبار الفشل فى اكتساب الوزن المتوقع.

4- قلة او زيادة النوم، بصورة يومية تقريبًا.

5- هياج أو تأخر نفسى حركى، تقريبًا كل يوم (يلاحظ من خلال الاخرين وليس فقط من خلال احساس ذاتى بعدم الراحة restlessness أو بالهبوط Slow down).

6- الارهاق أو فقدان الطاقة تقريبًا كل يوم.

7- مشاعر بعدم القيمة، أو الشعور المفرط بالذنب (والذى قد يكون ضلاليًّا)، تقريبًا كل يوم (ليس مجرد تأنيب الذات self-reproach او احساس بالذنب لكونه مريض).

8- القدرة المتناقصة على التفكير أو التركيز أو التردد، تقريبًا كل يوم (من خلال التقرير الذاتى أو الملاحظة من الاخرين).

9- افكار متكررة عن الموت (ليس مجرد الخوف من الموت)، أو أفكار انتحارية متكررة دون وجود خطة محددة، أو وجود محاولات انتحار، او وجود خطة محددة للانتحار.

(ب) تسبب الأعراض كربًا كبيرًا إكلينكيًّا، أو تدهورًا فى الوظائف الاجتماعية، او الوظيفية أو أى جوانب أخرى مهمة.

(ج) لا تكون الأعراض نتيجه للتأثير الفسيولوجى المباشر للمواد النفسية أو أى ظروف طبية أخرى.

ملحوظة
تمثل الأعراض من (أ- ج) نوبة الاكتئاب الأساسى.

د- لا يتم تفسير نوبات الاكتئاب الرئيسى من خلال اضطرابات الاكتئاب الوجدانى، أو الفصام، أو الاضطراب فصامى بشكل schizophreniform disorder، أو الاضطراب الضلالى، أو اضطرابات الطيف الفصامى المحددة أو غير المحددة، أو الاضطرابات الذهانية الاخرى.

هـ- يجب أن لا تكون هناك أى نوبات (سابقة أو حالية) من نوبات الهوس أو الهوس الخفيف.

ملحوظة
هذا الاستثناء لا ينطبق إذا كانت جميع النوبات الهوسية أو الهوسية الخفيفة ناتجة عن تعاطى المخدرات أو عن تأثيرات فسيولوجية لظروف طبية أخرى.

و يتم تصنيف الاكتئاب وفقًا للشدة إلى:

- ✓ بسيط Mild.
- ✓ متوسط Moderate.
- ✓ شديد Sever.

على الرغم من أن ردود الافعال نتيجة فقدان الأشياء المهمة، مثل (الفقد bereavement، الافلاس، الفقد نتيجه الكوارث الطبيعية، أو الأمراض الخطيرة، أو الاعاقة) تتضمن احساس قوى بالحزن، واجترار حول الفقد، واضطراب النوم، وفقدان الشهيه، وفقدان الوزن، كما هو موجود فى المعيار أ، والتى ربما تمثل نوبة اكتئاب، إلا أن تلك الأعراض قد تكون مبرره أو متناسبة مع الفقد، لذا فتشخيص نوبة اكتئاب رئيسى فى ظل وجود ردود الأفعال الطبيعية للفقد يجب أن ينظر إليها بعناية، وهو بالتالى يستلزم مراعاة التاريخ السابق والعوامل الثقافية للتعبير عن الكرب الخاص بالفقد.

ولتمييز أهم ملامح اختلاف اكتئاب الفقد Grief Depression عن نوبة الاكتئاب الرئيسى يمكن النظر إلى أن المشاعر المسيطرة فى اكتئاب الفقد هى مشاعر الفراغ والفقد، أما نوبه الاكتئاب الرئيسى فتتميز بمزاج اكتئابى مستمر وعدم القدرة على توقع السعادة والمتعة، كما أن هبوط المزاج dysphoria فى اكتئاب الفقد من المحتمل ينخفض فى شدته خلال أيام أو أسابيع، أو يحدث (أى هبوط الزاج) بشكل غير منتظم و التى تسمى بالالام الفقد Pangs of grief، وتكون مصحوبة بأفكار أو ذكريات عن المتوفى.

وفى الاكتئاب الرئيسى يكون الاكتئاب أكثر استمرارية ويتعلق بأفكار أو انشغالات خاصة، كما أن ألم الفقد ربما يصاحب بمشاعر إيجابية وروح فكاهية لا توجد فى الاكتئاب الرئيسى، كما أن محتوى الأفكار فى اكتئاب الفقد يكون مصحوب بأفكار وذكريات عن المتوفى اكثر من اجترارات متعلقة بإنتقاد الذات واجترارات تشاؤمية موجودة فى نوبة الاكتئاب الرئيسى، كما لا يتأثر تقدير الذات فى اكتئاب الفقد، أما فى نوبه الاكتئاب الرئيسى فيظهر احساس بعدم القيمة وكره الذات self – loathing.

تعريف الاكتئاب:

يشير روزنهان ROSENHAN وسليجمان SELIGMAN الى ان الاكتئاب اضطراب وجدان يتسم بأربع فئات من الاعراض هي:

اولا اعراض وجدانية

1- مزاج متعكر

ونقدر هذا الشعور بمقداره (شدته) ودوامه فقد يوجد في فترات معينة مثلا يقول انا اكون في اسؤ فترتي الصباح او بعد الضهر او المساء بيظهر لينا في تعبيرات الوجه الحزينه غياب الابتسامة شعور مستمر بالحزن وخيبة الامل والاحباط والتعاسة من خلال التقرير الذاتي او ملاحظة الاخرين

2- فقدان القدرة على الاستمتاع

نادرا ما يضحك او يبتسم استجابة للنكته او موقف طريف يستجيب بنظره جامدة وبوجه يخلوا من التعبيرات

المحك التالت

5 من باقي اعراض الاكتئاب

-

ثانيا الاعراض المعرفية (التفكير)

1-انخفاض في القدرات المعرفية

بطئ التفكير يشعر بالاجهاد الشديد عند التفكير في ابسط الاشياء هنا وكأن الافكار السلبية اصبحت تعوق مجري التفكير

2- الشعور بالذنب

بيوصف بكونه عرضا معرفيا لأنه يفترض ان يعكس طريقة تفكير اسمها العزو الداخلي ووطريقة العزو الداخلي في التفكير هي ان يرجع لنفسه كل الاحداث السيئه ونجد احيانا الموضوع اخد شكل غير واقعي فنجد المرأه التي تبلغ خمسين عاما تعاني من عذاب الضميرا لانها ابتسمت لزميلها في الجامعه لما كان عندها 18 سنة والراجل المسن بيلوم نفسة لانه تخلي عن حبيبته من اربعين سنه ويبدا المرضي في عملية تنقيب وبحث في ماضيهم لأرضاء هذه النزعه من الشعور بالخطيئه والذنب ويبدا يغرق نفسه في جرائم مالية واخلاقية

3- الشعور بعدم الاهمية والتفاهه والحط من قدر الذات

وهذه ايضا توضع تحت قائمة الاعراض المعرفية الخاصة بالتفكير لانه ببساطة الحط من قدر الذات ناتج عن الادراك المشوة للذات اي ادراك سلبي للذات منفصل عن الواقع فيبدأ يشعر بالدونية والاحتقار الذاتي فيبدأ يوصف نفسة باحط الاوصاف واقساها

4- اليأس

بمعني ان انه يتوقع دايما ان المستقبل سياتي من غير تحسن واما اسؤ من الحاضر وانه لا توجد اي امكانية لحل مشكلات ولا امل في حلها وان الاغلب انها سوف تستمر في الزيادة

ثالثا اعراض جسمانية

1- الام واوجاع جسدية

فنجد ان المكتئب يعاني من عدد من الاعراض الجسديه فتجده يقول :

- حاسس بصداع مزمن حاسس
- بحاجه طابقه علي صدري
- حاسس بتقل في عيني شبورة علي عيني
- في حشرجة في زوري
- وجع في مفاصلي زي شكشكه في مفاصلي
- الم اسفل الظهر
- الم في الرقبة
- حرقان في المعدة – قئ مستمر – قرح في المعدة
- قولون عصبي
- عضلاتي مشدوده – اعصابي ملتهبه

2- اضطرابات في النوم

ارق شديد يجعل حياته عباره عن سلسله من المعاناه احلام مزعجه وكوابيس تقيلة واحيانا ينام ويستيقظ صباحا ولكنه يستيقظ وكانه قطع رحلة مضنية شاقه

وتعالوا نتعرف علي انواع الارق :

الارق الابتدائي (اول النوم)يعني صعوبة الدخول في النوم ابتداء

الارق الاوسط وهذا اصعب نوع من الارق وهو يكون منتشر عادة بين مرضي الاكتئاب وهو اليقظة في الفجر او الساعة الثانية او الثالثه صباحا بعد النوم بفترة بسيطه وهذا النوع من الارق عادة ما يكون مصاحب للاكتئاب الحاد

الارق النهائي وهو الارق الصباحي وهو الاستيقاظ مبكرا

واخيرا زيادة النوم

3- مشكلات في الشهية او الاكل

- ليس لديه شهيه او بياكل بشراهه
- الميزان بيتغير 5 كيلو زيادة او نقصان

4- التعب

- سرعة التعب الضعف والوهن العام

رابعا الاعراض السلوكيه

1- التاخر النفسي الحركي

انخفاض في النشاط الحركي نتيجة فقدان الهمه

سرعة الايقاع بطيئه قلت ايقاع الحياة نفسة اصبح بطئ هناك فرق وقت مابين المثير والاستجابة

2- التهيج النفسي الحركي

تزيد الحركة ويكون هناك عدم استقرار فرك اليدين , رعشة في اطرافه ,كثرة الكلام يعبر عن ضيقه وحزنه ومشاعره بالصراخ واحيانا العدوان

3- الانسحاب السلوكي

اعاقه في الحياة سواء علي المستوي الاجتماعي او المستوي الوظيفي واحيان تصل الي حد عدم الحركة والشلل التام ويصاب بما يسمي الغيبوبة الاكتئابيه

4- الانتحار

50 الي 70 % من حالات الانتحار سببها الاكتئاب محاولات الانتحار في الاكتئاب هي محاولات حقيقه جدا وجادة جدا واحيانا ما يصاحب عملية الانتحار قتل بعض او احد الاعزاء او الاقرباء ليس رغبة في القتل بل اعتقادا منه انه بينقذ احباءة من هذه الحياه التعسة المظلمه

فالانتحار بيمر بعدة مراحل حتي يتحول الي انتحار

- تمني الموت تمني الموت معناه رغبه قوية في انتهاء الحياه (يعني يارب لو مش خير عجل بقضائي)
- افكار انتحارية زي ايه (اني هكون افضل لو مت) (عيلتي هتستريح مني لو انا مت) (الحل الوحيد لكل مشاكلي اني اموت نفسي) (ماحدش بيهتم بيا فالافضل اني اموت)
- نوايا انتحارية (انا هنتحر اول ما تجيلي فرصة هنتحر قريب جدا)
- خطط انتحارية هنا تحول الامر من نيه الي دافع وكل ما يكون خطط الانتحار في وجود الاخرين كان الامر اقل خطورة
- استعدادات انتحارية (شراء المسدس مثلا)
- تنفيذ محاولة انتحارية

ويمكن عن طريق الاختبارات المستخدمة في الاكتئاب قياسه والكشف عنه وتحديد شدته:

1-قائمة بيك

2-مقياس هاملتون

3-اختبار MMBI

النماذج والنظريات المفسرة للاكتئاب:

1-العوامل الوراثية والعصبية والكيميائية:

تستند النماذج الوراثية في تقسيم اضطراب المزاج الى نتائج البحوث التي أجريت على العائلة او التوائم او الأشخاص المتبنين,وتوصلت الى وجود استعداد وراثي للاضطراب الاكتئابي الأساسي والاضطراب ثنائي القطب.

كما يشير عدد من الدراسات الى ان نسبة الإصابة بذهان الهوس والاكتئاب بين التوائم المتماثلة الذين نشأوا منفصلين بالتبني وصلا 67% ولدى التوائم المتماثلة الذين نشأوا معا 68% في حين بلغت النسبة لدى التوائم غير المتماثلة 23%(عبد الستار إبراهيم-1998) كما ان هناك عددا من الدلائل والمؤشرات لوجود أساس فسيولوجي وعصبي للأكتئاب حيث تشير نتائج بعض الدراسات الى حدوث تغيرات فسيولوجية تصاحب الاعراض الاكتئابية,كذلك وجد ان هناك بعض مناطق المخ تختص بنقل الخبرات الوجدانية وهي منطقة قاعدة المخ والمعروفة بالهيبوثلاموس والجهاز العصبي الذاتي.(شعبان جاب الله رضوان-1992)

بالإضافة الى هذا وجد ان مادة النورادرينالين ترتبط بالسلوك الوجداني حيث يتعرض الفرد للاكتئاب والبطء النفسي الحركي عندما يتم ابطال مفعول هذه المادة من خلال عقاقير معينة كما يحدث العكس عندما تنشط هذه المادة في مناطق الاستقبال بالمخ(يوجين ليفيت,برنارد لوبين-1985)

ويشير احمد عكاشة الى أن العقاقير التي تقلل نسبة بعض الهرمونات العصبية في المخ خاصة السيرتونين والادرينالين والدوبامين تسبب أعراض اكتئابية كما تبين ان هذه الهرمونات توجد في المناطق الخاصة بالانفعال وخاصة الهيبوثلاموس والجهاز الطرفي في السطح الاسي للمخ بنسبة اعلى من أي جزء اخر في الدماغ بما يدعم دور الهرمونات العصبية في نشأة الاضطرابات الاكتئابية(أحمد عكاشة-1998)

2-التفسيرات المعرفية:

يؤكد المحنى المعرفس أهمية الدور الذي تؤديه المتغيرات المعرفية كالنظرة السلبية نحو الذات والعالم والتفسير الخاطىء للاحداث الشخصية في نشأة مظاهر الاكتئاب لدى الفرد.ويعد هذا المنحى المعرفي ذا أهمية كبيرة في تفسير نشأة الاكتئاب واستمراره وتفاقمه,حيث قامت على أسسه النظرية فنيات العلاج المعرفي بمختلف توجهاته,وتشترك النماذج والنظريات

المعرفية للاكتئاب في النظر اليه باعتباره محصلة لمجموعة من الأفكار والمعتقدات والتصورات الخاطئة او السلبية وغيرالعقلانية,والتي يسعى العلاج المعرفي بمختلف توجيهاته وفنياته الى تعديلها.

أ)نموذك بك للاكتئاب:

قدم بك الأفكار المبكرة لنموذجه 1963,ثم نشر صياغة منقحة لنظريته 1967,وتضمنت مؤلفاته التالية صياغات لنظريته في الاكتئاب مع ابراز دلالاتها وتطبيقاتها العلاجية للاضطرابات الاكتئابية.

ويقوم النموذج المعرفي الذي صاغه بك على ثلاثة مفاهيم أساسية هي:

1-الثاوث المعرفي Cognitive Triad

2-المخططات Schemata

3-الأخطاء المعرفية Cognitive Errors

1-الثالوث المعرفي:

يشير الثالوث المعرفي الى اتجاهات الفرد السلبية وتصوراته المشوهة نحو الذات والعالم والمستقبل ويتضمن العنصر الأول النظرة السلبية نحو الذات,حيث يرى الفرد نفسه غير ذي قيمة,ويميل الى تعليل خبراته السلبية بوجود اختلال نفسي او أخلاقي او جسمي في ذاته,كما يميل الى النقد المستمر لذاته.

ويتضمن العنصر الثاني النظرة السلبية نحو العالم ميل الفرد المكتئب الى تفسير خبراته بأسلوب سلبي حيث يدرك ان العالم يفرض عليه مطالب قاسية ويضع العقبات التي يصعب تقليلها في طريقة الوصل الى أهدافه في الحياة,كما يسيء تفسير تفاعلاته مع بيئته الاجتماعية والمادية.

اما العنصر الثالث من هذا الثالوث المعرفي فيشير الى النظرة السلبية نحو المستقبل,حيث يقوم الشخص المكتئب بتقدير الاختمالات المستقبلية لفترة طويلة,ويتكون لديه اعتقاد بان مشكلاته ومعاناته الحالية سوف تستمر في المستقبل,كما يتوقع الفشل في مهام محددة في المستقبل القريب.

2-المخططات:

والمخططات عباره عن تكوين معرفى افتراضى يقوم بتوجيه (التحكم فى) معالجة المعلومات، وبالتالى مرضى الاكتئاب لديهم مخطط معرفى سلبى حول الذات، يؤدى الى معالجة المعلومات الشخصية بطريقة سلبية ومشوهه ومتحيزة، حيث يميلون الى التركيز على الجوانب السلبية فى حياتهم، ويفسرون الاحداث السلبية بطريقه انهزامية، وهذه المعالجات السلبية والمتحيزة للمعلومات تؤدى بالتالى

الى زيادة واستمرار الثالوث المعرفى السلبى، وبالتالى تفسر تلك المخططات اسباب استمرار المعاناه والافكار الانهزامية لدى مرضى الاكتئاب على الرغم من وجود أدله موضوعية مناقضة لمعتقدات المريض.

وعندما تنشط المخططات تؤدى الى تدهور خاص فى الانتباه والتفسير والذاكرة، حيث يميل الاشخاص المكتئبين الى التنبيهات المنسجمه مع المزاج mood congruent stimuli، مع تجاهل واستبعاد المعلومات الايجابية، وتؤدى تلك العملية الى تقليل المشاعر الايجابية حتى أثناء الاحداث السارة.

اما بالنسبة للذاكره توجد أدله على وجود تحيز فى الذاكره لدى مرضى الاكتئاب، حيث يميل هؤلاء المرضى (أو يظهرون تفضيلات) الى تذكر الاحداث السلبيه اكتر من تذكر الاحداث الايجابيه، وقد اشارت الدراسات الى ان تدهور فى الانتباه والذاكرة مرتبطان بالخلل فى عمليه الكفinhibitory deficits، حيث يظهر الاشخاص عدم القدرة على كف التنبيهات السلبية، فالعديد من الدراسات اشارت الى أن الخلل فى عملية الكف يظهر اكلينيكيًا فى صوره الاستجابه الاجترارية ruminative response style، والتى تؤدى الى استمرار الافكار السلبية (الثالوث المعرفى).

فالميول لمعالجه المعلومات بطريقه مشوهه تؤدى الى تفسير المواقف بطريقه غير واقعيه وخاطئة، وتتضمن تلك الميول المشوهه فى معالجه المعلومات ما يلى:

1- التجريد الانتقائى selective abstract: وفيه يقوم المريض بالاهتمام ببعض التفاصيل ويعزلها عن السياق الذى تقع فيه، او يركز فقط على الجوانب السلبية فى الحدث، فى حين يتجاهل الجوانب الاخرى.

2- الاستدلال التعسفى arbitrary inference: وهى تعنى الوصول الى استنتاجات خاطئة على الرغم من عدم وجود ادلة تؤيد تلك الاستنتاجات "لو فشلت فى الامتحان هفشل فى اى مشروع فى حياتى".

3- التعميم الرائد over generalization: وهو يعنى تعميم استنتاج من مواقف سابقة على جميع المواقف المشابهه، فالفشل فى مقابلة عمل واحدة تؤدى الى التنبوء بالفشل فى جميع مقابلات العمل اللاحقة (يؤدى الى الشعور باليأس) أو تعميم انطباع ما على مجموعة من الاشخاص المتجانسين، أو الفشل فى علاقه عاطفية تعنى فشل فى جميع العلاقات اللاحقه.

4- التفكير المطلق او الثنائى absolutistic or dichotomous thinking: وهو يعنى التفكير بشكل قاطع او وضع الاشياء فى فئات او تصنيف الاشياء على طرفين متناقضين مثل الابيض والاسود، كأن يرى الشخص نفسه على أنه ناجح أو فاشل أو يرى الاخرين على انهم سيئين او جيدين.

وتؤدى تلك المعالجات المتحيزة للمعلومات إلى زياده حده الاكتئاب، وتعمل على انفصال العلاقات بين المواقف الحقيقية والتفسيرات السلبية لها، مما يؤدى الى تشوه الواقع ويفتقد المريض القدرة على رؤية افكاره على انها خاطئة.

3- الأخطاء المعرفية:

هناك العديد من المحاولات التى هدفت لتحديد أكثر التشوهات المعرفية او المعتقدات غير المنطقية irrational beliefs لدى مرضى الاكتئاب، وكان من اشهر تلك المحاولات ما قام به "دافين بيرنز" David Burns (1980)، حيث أشار الى وجود عشره أنماط من تشوهات التفكير التى تميز مرضى الاكتئاب، وهى:

1- تفكير الكل أو اللاشيئ All or None thinking: ويسمى هذا النوع أيضًا بتفكير الابيض والاسود Black or white thinking، ومن خلاله يرى الاشخاص الأشياء والمواقف على أنها عبارة عن فئتين فقط هما: الابيض والاسود "فمثلًا عندما لا يكون الأداء مثاليًّا تمامًا يرى الشخص نفسه على انه فاشل تمامًا.

2- التعميم الزائد over generalization: ومن خلاله يرى الشخص حدثًا سلبيًّا على انه جزء من سلسلة لا تنتهى من الأحداث السلبيه الأخرى، أو يقوم الشخص بتعميم استنتاج من موقف خاص الي موقف عام او قاعدة عامة.

3- الفلتر الذهنى Mental filter: ومن خلاله يقوم الشخص بالتركيز على الأحداث السلبية ويهمل الأحداث الإيجابية، أو يقوم بالتركيز على الجوانب السلبية فقط للحدث، مما يجعل تلك الجوانب السلبية تظلل الموقف بأكمله، مثل بقعه الحبر التى لوثت كوب المياه النظيف.

4- رفض ردود الفعل الايجابية Disqualifying the positive: حيث يقوم الشخص برفض ردود الأفعال الإيجابية من الآخرين، أو يرفض الخبرات الإيجابيه لانها لا تعنى شيئًا كبيرًا بالنسبه له، مما يؤدى الى استمرار احتفاظ الشخص بالمعتقدات السلبية حول ذاته على الرغم من وجود خبرات إيجابيه تناقض تلك المعتقدات.

5- القفز إلى الاستنتاجات Jumping to conclusions: حيث يقوم الشخص بالوصول الى تفسيرات سلبية على الرغم من عدم وجود ادلة تؤيد تلك الاستنتاجات، وينقسم الى نوعين فرعيين هما:

أ- قراءه العقل Mind reading: يعتقد المريض أن شخصًا ما يتفاعل معه بشكل سلبى "هو بيستحقرنى" دون أن يهتم بالتحقق من ذلك الاستنتاج، وفى الغالب يكون نوع من الاسقاط، حيث أنه يسقط فى الغالب ما يعتقده عن نفسه.

ب- قراءه المستقبل the fortune teller error: يتوقع المريض أن الأمور سوف تكون اسوأ فى المستقبل، مع الاقتناع بأن هذا التنبؤ حقيقه مثبتة.

6- التضخيم (التفكير الكوارثى) أو التهوين والتصغير magnification (catastrophizing) or minimization: وفيه يقوم الشخص بالتضخيم من الأحداث أو الصفات السلبية الخاصة به، أو تضخيم انجازات الأشخاص الآخرين (التضخيم)، أو بقوم بالتقليل من قدراته او صفاته الايجابية، أو يقلل من عيوب الاخرين، و هى ما تسمى بـ "خدعه المنظار" Binocular trick.

7- الاستدلال العاطفى Emotional Reasoning: حيث يفترض المريض أن مشاعره السلبية تعكس الحقائق من حوله "إذا كنت اشعر ان شخص يكرهنى فهو فى الحقيقه يكرهنى"، "انا حاسس انى فاشل، علشان كده اكيد انا فاشل".

8- عبارات "يجب" أو "ينبغى" should statements: حيث يقوم الشخص بتحفيز ذاته على فعل شيئ ما من خلال استخدام تلك العبارات، و لكن تلك العبارات تمثل فى طبيعتها أدوات جلد وعقاب للشخص، لذلك يشعر المريض دائمًا مع مثل تلك العبارات بالذنب "أنا لازم أرضى كل الناس"، أما عندما تتعلق تلك العبارات بما ينبغى أن يكون عليه الآخرون "المفروض كل الناس تراعى مشاعرى" فإنها تؤدى الى مشاعر استياء وغضب واحباط تجاه الاخرين.

9- التصنيف وسوء التصنيف Labeling and Mislabeling: ويعد ذلك صوره متطرفة من التعميم الزائد، فبدل من أن يصف الشخص سلوكه "انا اخطأت فى كذا" يقوم بإلصاق صفة سلبيه لذاته "انا سيئ" "انا فاشل".

أما سوء التصنيف فهى تتضمن وصفًا لأحداث أو أشخاص بطريقه مشحونة انفعاليًا، ويغلب عليها الطابع المزاجى السائد "هو أحمق" " فاجر".

10- الشخصنة Personalization: حيث يرى الشخص أنه مسئول بصورة كبيرة عن بعض الأحداث الخارجية السلبية مع اهمال بعض العوامل الاخرى أو الاسباب الأخرى "أنا السبب إن ابنى اللى فى الجامعه مجبش درجات كويسة" "أنا اللى موت ابنى علشان كنت المفروض اكشف عليه عند اكثر من دكتور".

3-التفسيرات السلوكية:

تقدم النظريات السلوكية نموذجين أساسيين في تفسير الاكتئاب,يشير النموذج الأول الى ان الاكتئاب ينشأ من مستويات منخفضة من الاثابة او مستويات مرتفعة من العقاب او من كليهما,اما النموذج الثاني فيفسر الاكتئاب على انه أنماط سلوكية متعلمة,وتظل هذه الأنماط قائمة لانها تؤدي الى اثابة الفرد مثل التعاطف والدعم من الاخرين ووفقا لذلك يسهم نقص الاثابة وزيادة العقاب غي نشأة الاكتئاب (النموذج الأول) كما تسهم الاثابة في استمراره أيضا (النموذج الثاني) بعد اكتسابه من خلال سلسلة من الارتباطات بين المنبهات المختلفة,فيفسر سكنر ولازاروس الاكتئاب بانه يحدث نتيجة لانخفاض التدعيم الإيجابي,فالاشخاص المكتئبون وفقا لهذا التصور ينسحبون من الحياة لعدم وجود حوافز لديهم تجعلهم اكثر نشاطا,فبدون التدعيم المستمد من اهتمام الاخرين يكون هناك احتمال لان يصبح الفرد مكتئبا وقد يظل مكتئبا لفترات طويلة اذا كانت هناك مكاسب ثانوية للمرض مثل عدم تحمل المسؤلية عن الذات والاخرين,كما ركزت التفسيرات السلوكية حديثا على دور أحداث الحياة الضاغطة في نشأة الاكتئاب.

وهناك دلائل مستمدة من نتائج بعض البحوث تشير الى ان الطلاب المكتئبين كانوا يتلقون من أقرانهم إثابة اقل وعقابا اكقر مقارنة بغير المكتئبين ,كما ان الأشخاص المكتئبين ينجذبون نحو الأشخاص الذين ينظرون اليهم بطريقة غير ودية ويلتمسون الحصول على عائد غير سار من الاخرين,كما اتصفوا بعدم الكفائة الاجتماعية,وانخفاض الفاعلية في حل المشكلات الاجتماعية

كما يشير بعض الباحثين الى أهمية الاثابة الذاتية والعقاب الذاتي ودورهما في نشأة الاكتئاب حيث يعطي الأشخاص المكتئبون انفسهم إثابات أقل وعقابا اكثر لما يصدر عنهم من سلوك.

ومن ثم نجد ان التفسيرات السلوكية تركز على دور الاثابة والعقاب في نشأة الاكتئاب وفي استمراره,كما تنظر الى الاكتئاب على انهانماط سلوكية خاطئة ثم اكتسابها من خلال الروابط بين المنبهات المختلفة.

المتغيرات المهيئة والمرسبة للاكتئاب وفقا لنموذج بك:

يقوم نموذج بك للاكتئاب على فرض مفاده ان الخبرات والاحداث المبكرة التي يتعرض لها الفردفي حياته تقدم الأساس الذي يعتمد عليه في تكوين التصورات السلبية نحو الذات والعالم والمستقبل وهذه التصورات السلبية هي المخططات التي تثار من خلال ظروف او مواقف محددة تشبه تلك الخبرات المسؤلة أساسا عن نشأتها وتكوينها لدى الفرد,فمثلا يمكن لمرض جسمي ان ينشط اعتقادا كامنا لدى الفرد مفاده انه مقدر له حياة مملوءة بالمعاناة ويكون هذا الاعتقاد قد تكون نتيجة تعرضه لمرض جسمي مثلا في مرحلة مبكرة من حياته,وعندئذ ينشأ الاكتئاب ما لم يكن الفرد مهيأ للتأثر بأحداث معينة وفقا لمضمون او محتوى تنظيمه المعرفي.

واستنادا الى ذلك يمكن القول بأن الخبرات المبكرة المسهمة في تكوين المخططات تعد بمثابة المتغيرات المهيئة اما الاحداث السلبية المنشطة لهذه المخططات فتمثل المتغيرات المرسبة للاكتئاب.

ويشير بك الى ان عمليات التقويم التي يقوم بها الفرد ويعلل فيها الاحداث السلبية بوجود اختلال شديد في ذاته,تفصح عن انخفاض في تقدير الذات ويتجه تقدير الذات نحو مزيد من الانخفاض عندما يقارن الفرد نفسه بالاخرين.

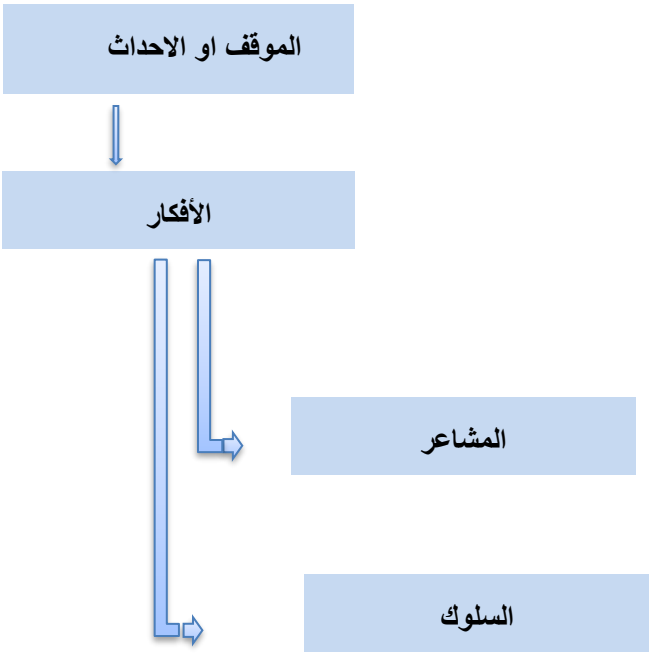
هذا هو الاطار العام لنظرية بك المعرفية في الاكتئاب والتي تعتمد أساسا على نموذج معالجة المعلومات حيث يتضح المظهر السلبي لهذه العملية (معالجة المعلومات) في اضطراب التفكير المميز للاكتئاب والمتمثل في بعض الأخطاء المعرفية المنظمة التي اشرنا اليها من قبل.

ومع هذا التأكيد لدور الجوانب المعرفية ,يحاول بك ان يلفت الانتباه الى دور بعض المتغيرات الاجتماعية كالرفض الاجتماعي في اثارة تصورات سلبي تؤدي الى الاكتئاب,كما يشير الى أهمية العلاقات الشخصية المتبادلة التي تتسم بالود والتقبل من حيث قيامها بدور رئيسي في المساندة الاجتماعية للفرد,والتي تؤدي بدورها الى خفض مظاهر الاكتئاب لديه ,وهناك دلائل ومؤشرات إمبريقية (واقعية) متراكمة تدعم صدمة التنبؤات المشتقة من هذا النموذج المعرفي للاكتئاب,بالإضافة الى هذا هناك تطبيقات علاجية تعتمد على هذا النموذج تتمثل في أسلوب العلاج المعرفي للاضطرابات الوجدانية.

وتجدر الإشارة الى ان نموذج بك المعرفي للاكتئاب كما عرضنا له,لا يتناول الجوانب الأخرى التي يمكن ان تسهم في نشأة الاكتئاب ومنها الاستعداد الوراثي والعوامل الفسيولوجية والبيوكيميائية والعصبية ,لكنه لا ينكر دور هذه العوامل في نشأ الاكتئاب.

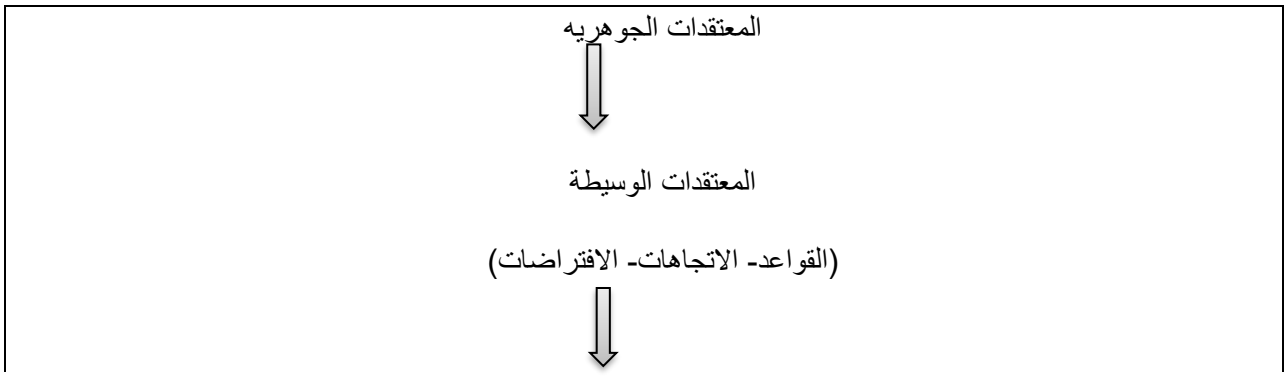
العلاج المعرفى السلوكى للاكتئاب:

يقوم العلاج المعرفي بشكل اساسي علي النموذج المعرفي (انظر الشكل التالي)



ويسمي هذا النموذج بـ ABC model حيث يمثل A الموقف الذي يتعرض له الشخص، اما B فهي الافكار التي يفكر فيها الشخص عن الحدث او عن نفسه، اما C فهي اما Ce وتعنى المشاعر المترتبه علي الافكار، وإما Cb اي السلوك الذي يترتب علي الأفكار أو المشاعر.

حيث يفترض النموذج المعرفي بشكل عام ان مشاعر الاشخاص وسلوكياتهم تتاثر بادراكهم للاحداث، فالمواقف التي يتعرضون لها ليست هى من تحدد الطريقه التي يشعرون بها او الطريقه التي يتصرفون بها، ولكن يتم التحكم في المشاعر والسلوك من الطريقه التي يفسرون بها تلك الاحداث، وهو ما يعنى اهميه الافكار وطريقه التفكير في العلاج النفسي.



الافكار التلقائيه

التصور المعرفى Cognitive conceptualization للاكتئاب الرئيسى:

التصور المعرفى (أو صياغة الحالة) هو فهم فردى ومفترض لمشكلات المريض فى إطار النموذج المعرفى للاكتئاب، وهو فى جوهره يهدف الى الكشف عن العوامل التى ادت إلى استمرار مشكلات المريض الحالية، والكشف عن العوامل الكامنة التى أدت إلى المشكلة، وبالتالى تعمل الصياغة المعرفيه كأساس لعمل خطه العلاج الفردية Idiosyncratic treatment plan وكموجه عام للعلاج.

وبدون الصياغة المعرفية من المتوقع أن تُستخدم التكنيكات والتدخلات العلاجية بطريقة فوضاوية وغير منظمة، لأن ذلك سوف يدفع المعالج إلى فهم متسرع لمشكلات المريض، لذا وصف "بيك" الصياغة المعرفية بأنها خارطة طريق، أما الاهداف العلاجية فهى المكان المستهدف الوصول اليه.

والصياغة المعرفية تبدأ منذ الجلسات الاولى وتستمر حتى نهاية العلاج، ويتم ادخال التعديلات عليها أو تغذيتها فى اطار المعلومات الجديدة، وقد اشار"ويلز" و "ساندر" wills and sanders (1997) أن التصور المعرفى الجيد هو الذى يساعد المريض على الاجابة على الأسئلة مثل: "ليه انا اللى جالى اكتئاب"، " ليه جالى دلوقتى"، "ليه الاكتئاب مستمر"، "ازاى ممكن اتغلب على الاكتئاب"، وينبغى على المعالج ان يشرك المريض فى تحديد دقه التصور، و مساعدة المريض على فهم نفسه ومشكلاته الحالية.

ملحوظة
يختلف التصور المعرفى للحالة عن التشخيص الطب النفسى، لانه يحاول أن يفهم التركيبة الداخلية للمريض و ليس تصنيف الاشخاص الى فئات معينة.

مخطط التصور المعرفي

اسم المريض: ..... التاريخ: .....

تشخيص المحور الاول: ..... التشخيصة: .....

معلومات هامه عن الطفولة (التجارب السابقه التي ساهمت في تكوين المعتقد الجوهري في مرحله الطفولة)
المعتقد الجوهرى (أهم معتقد مركزى المريض)
المعتقدات الوسيطة (الافتراضات – القواعد – الاتجاهات)
الاستراتيجيات التعويضية

الموقف 1	الموقف 2	الموقف 3
الفكره التلقائية	الفكره التلقائيه	الفكره التلقائيه
معني الفكره التلقائية	معني الفكره التلقائية	معني الفكره التلقائيه
المشاعر	المشاعر	المشاعر
السلوك	السلوك	السلوك

مثال حقيقى للتصور المعرفي لاحدى الحالات

معلومات عن الطفوله ذات علاقة - اهمال الأم وسلبيتها. - عدم قدرتها على تكوين صديقات فى المدرسة. - تعرضت لعدد من التحرشات الجنسية فى سن صغيرة.		
المعتقد الجوهري "محدش بيحبنى"		
المعتقدات الوسيطة "لو جيت على نفسى فى علاقتى مع الناس هيتمسكو بيا"		
الاستراتيجيات التعويضية (عدم طلب أى خدمات من الأخرين- عدم رفض طلبات الآخرين- البحث عن عيوب فى شخصيتها عند بدء أى علاقة- تقديم الهدايا للآخرين).		
الموقف 1	**الموقف 2**	**الموقف 3**
مشادة مع الأم	الدكتور مردش على التليفون	ذهبت الام مع الاخت الصغرى لزيارة الاخت الكبرى
الافكار التلقائية	**الافكار التلقائية**	**الافكار التلقائية**
"أمى مش بتحبنى"	"الدكتور شافنى صح عشان كدة بقى مش طايقنى"	لو كانو بيحبونى كانو عزمو عليا آجى معاهم
معني الفكره التلقائية	**معني الفكره التلقائية**	**معني الفكره التلقائيه**
"أنا مش محبوبة"	"أنا مش محبوب"	"مش محبوبة"
المشاعر	**المشاعر**	**المشاعر**
غضب	حزن	احباط
السلوك	**السلوك**	**السلوك**
كثرة المشاجرات مع الام	الاعتذار عن الجلسة	تجنب التواصل مع الاهل

ملحوظة: الاستراتيجيات التعويضية: هي الخطط التي يكونها المريض للتكيف مع المعتقد الجوهري المؤلم، أو هي عباره عن مجهود خاص (سلوكى- أو نفسى) يقوم به الاشخاص للسيطره على أو تحمل أو تقليل أو التعايش مع الاحداث الشاقة، ويوجد نوعين من

الاستراتيجيات التعويضية هي الاستراتيجيات النشطة (سلوك مباشر مثل العدوان، والشكوك، والحيطة والحذر) والاستراتيجيات التجنبية (مثل العزلة والهروب).

استراتيجيات العلاج المعرفى السلوكى:

يعد العلاج المعرفى السلوكى مزيجًا من نظريتين هما: النظرية المعرفية والنظريه السلوكية، وبالتالى يتضمن هذا العلاج نوعان من التكنيكات هما: التكنيكات المعرفية والتكنيكات السلوكية، بالإضافة إلى تعلم بعض المهارات الاجتماعية، وتستهدف تلك التكنيكات الدائره التى تعمل على استمرار اعراض الاكتئاب.

أولًا: الاستراتيجيات المعرفية:

بعد أن يتم الكشف عن الافكار والمعتقدات تاتي الخطوه التانية وهي تغيير تلك المعتقدات واستبدالها بافكار جديدة اكثر واقعية وتكيفية، وتتم عمليه استكشاف الافكار والمعتقدات وتعديلها خلال جميع مراحل العلاج المختلفة.

كما أننا لا نستهدف كل أفكار ومعتقدات المريض السلبية، بل نتستهدف المعتقدات التي تزيد درجه الاعتقاد فيها عن 50%، ويتم تعديل تلك الافكار حتي يصل درجه الاعتقاد فيها علي الاقل من 20 %، فليس شرطًا ان تصل الي صفر %.

وسوف نعرض مجموع من الاستراتيجيات (التكتيكات) المعرفيه لتفنيد وتغيير الافكار التلقائية والمعتقدات الوسيطة والجوهرية، وتشمل تلك الاستراتيجيات على:

1- جدول المراقبة الذاتية Dysfunctional thought Record:

وهى طريقة علاجية تهدف إلى رصد وتسجيل الأفكار التلقائية، ثم القيام بعملية اختبار الواقع لتلك الأفكار والكشف عن التحيزات وتشوهات التفكير، للوصول إلى أفكار متوازنة واكثر واقعية.

جدول المراقبة الذاتية للأفكار السلبية

اليوم/ الساعة	نوع الانفعال ودرجته (0-100%) - اقرأ قائمة الانفعالات	الموقف أو الشخص أو الحدث	الفكرة ودرجة الإيمان بها (0-100%)	الأفكار البديلة (بعد قراءة الأسئلة السقراطية)	- درجة الاعتقاد بالفكرة البديلة - الانفعال الناتج عنها ودرجته.

2- الاسئلة السقراطية Socratic questioning:

هي مجموعه من الاسئله التي يوجهها المعالج حول فكرة أو معتقد، بهدف مساعدة المريض على إعادة النظر في افكاره غير الواقعية او النظر للافكار بطريقة مختلفة، وتتمثل تلك الاسئلة فى:

- **ما دليل صحة هذه الأفكار أو المعتقدات اللاعقلانية فى حياتك؟**
- **ما أدلة عدم صحة هذه الأفكار والمعتقدات فى حياتك؟**
- **إذا كانت هذه الفكرة صحيحة ما أسوأ ما يمكن أن يترتب على هذه الفكرة؟ وكيف تتوافق معها؟**
- **إذا كان لك صديق أو زميل أو جار فى نفس ظروفك ولديه نفس الفكرة، ما الذى يمكن ان تنصحه بها؟**
- **ما الفكرة البديلة التى وضعتها للفكرة القديمة؟**

ويتضح من تلك الاسئلة أنها تتجنب المواجهة المباشرة مع أفكار المريض، ولكنها تثير بعض الشكوك فى المريض حول تلك الافكار بشكل غير مباشر، وتساعد المريض على التقييم الواقعى لأفكاره.

3- التجارب السلوكية Behavioral experiment:

تستخدم التجارب السلوكية لاختبار صحة او صدق الافكار التلقائية والمعتقدات الوسيطة (الافتراضات والقواعد)، فرغم وجود كم كبير من الافكار لدى المرضى، إلا أنهم يحرمون أنفسهم من أى فرصة لاختيار تلك الافكار، هنا يقوم المعالج بالاتفاق مع المريض حول تصميم تجربة حياتية واقعية ليختبر بها المريض صحة معتقداتة بصورة واقعية، ويعد هذا الاسلوب من اهم اساليب العلاج النفسي لانه يختبر الافكار بطريقة واقعية ويمكن ان تستخدم بمفردها او تستخدم مع التكتيكات المعرفية الاخري مثل الاسئلة السقراطية، كما انها من الممكن ان تجري في الجلسه العلاجيه او تتم كنوع من الواجب المنزلي من أمثله الافكار التي يتم التعامل معها بالتجارب السلوكية "انا لو اتكلمت مع الناس هيضحكوا عليا" "انا معنديش ذاكره احفظ بها اي حاجه" "لو رفضت لاصحابى اى طلب هيبعدوا عني ويسيبوني" هنا يقوم المعالج بتصميم تجربه حقيقية مع الاشخاص المعنيين، ويري هل بالفعل ما يظنه المريض عن نفسه ("معنديس ذاكرة") أو عن الأخرين ("هيضحكو عليا" " هيبعدوا عني ويسيبوني") حقيقيا أم لا.

وبالتالي فهذه الطريقة هى عكس الطريقة الاولي (التي يتم تفنيد الافكار فيها بطريقه معرفيه شفهيه)، ويمكن ان تستخدم الطريقتين معا لتعديل نفس الفكرة مثال فكرة "انا لو اتكلمت قدام الناس هيضحكوا عليا" هنا بعد استخدام الاسئله السقراطية نصمم تجربة يقوم من خلالها المريض بالتحدث مع مجموعه من الاشخاص ويرصد ردود افعالهم.

ملحوظة

يتم تصميم التجارب السلوكية عندما نتاكد ان الواقع لا يؤيد تلك الافكار، اما اذا كان الواقع يؤيد هذه الفكره يقوم المعالج باستخدام طرق اخرى: مثل: حل المشكلات، وتوكيد الذات.

ويجب قبل إجراء التجربة السلوكية أن يتم تحديد خطوات تلك التجربة بدقة، ورصد توقعات المريض (أفكاره) أثناء التجربة "لو اتصلتى بزميلاتك تتوقعى هيتعاملوا معاكى ازاى"، "وده معناه إية"، "لو طلبتى انك تقابليهم تتوقعى ايه"، "وده معناه اية"، وربما درجه القلق أو الاكتئاب، وبعد انتهاء التجربه يتم عمل مقارانات بين تلك التوقعات قبل التجربة وما تم بالفعل اثناء التجربة، وعلى المعالج ان يتناقش مع المريض حول ما تم تعلمه، ومبرراته لنتائج التجربه، فمثلا فى تجربه صممت لمريض حول فكره "لو اتكلمت مع زمايلى هيضحكوا عليا"، بعد انتهاء التجربة برر المريض عدم ضحك أصدقائه بزيادة عدد الأصدقاء أثناء التجربة، وأنه لو قل عدد الأصدقاء فى الموقف سيضحكون عليه بالفعل، هنا يقوم المعالج بتصميم تجربه اخرى بعدد اصدقاء اقل، كما يطلب من المريض عدم ترك التجربه لاى سبب الا بعد فتره طويلة.

4- المتصل المعرفى Cognitive continuum:

غالبا ما تصاغ معتقدات المريض الأساسية السلبية وفقا لمصطلحات مبدأ الكل او لا شيء مثل (انت إما ناجح وإما فاشل في الحياة,وانا أحد إخفاقات الحياة),ان استخدام المتصل (مقياس يتراوح بين صفر و100%)يضفي اللون الرمادي على تفكير المرضى,مما يساعدهم على إجراء تقييمات أكثر توازن وواقعية لأنفسهم,وللأخرين والعالم(للوصول في النهاية الى نقطة منتصف هذا المتصل) ويقترح Padesky and Greenberger أن(المقياس او المتصل اكثر فائدة من الناحية العلاجية عند بناء وتقييم المخطط الجديد اكثر من المخطط القديم ,وعادة ما يكون التغيير البسيط الذي يعزز المخطط الجديد,اكثر فائدة للمريض من التغيير البسيط الذي يضعف المخطط القديم)

على سبيل المثال,اذا تم تقييم تغيير المخطط عبر متصل يركز على المعتقد القديم(انا عديم القيمة) فقد يقرر المريض انه(عديم القيمة الان بنسبة 60%) ويرى ان وظيفة العلاج هي مساعدته على الحد من الشعور بعدم الجدوى,في حين انه اذا تم تقييمه عبر متصل من خلال المعتقد الجديد (انا بخيركإنسان) فمن شأن ذلك اثارة التفاؤل حول أن نظرته الجديدة لنفسه تكتسب مزيد من الأهمية (لقد زادت بمقدار يتراوح بين 15 و20% منذ اخر مرة رأيتك فيها) وعندما يتكون المتصل,يجب على المعالج مساعدة مرضاه على تحديد نقطة النهاية على المتصل بصورة قاطعة حتى يتمكن من أن يروا بوضوح ان هناك تغييرا يحدث (اذا لم يكن هناك تباين واضح جدا بين هذه النقاط النهائية أي نقطة البداية ونقطة النهاية فسوف يجد ذلك من ادراك المريض لمقدار التغيير الذي يحققه) وفي المثال التالي,حددت النقطة صفر و50و100 % من قبل المريض:

المعتقد الأساسي الجديد(انا كفء بدرجة معقولة)

صفر%	%50	%100
غير كفء على الاطلاق	أحيانا كفء واحيانا لا	كفء دائما

يطلب من المريض ان يضع علامة x على موضعه المتصل (مثلا:10%) ويمكن ان يكون المتصل نقطة مرجعية لمراقبة تقدم المرضى نحو نقطة المنتصف, استنادا الى المعلومات والأدلة التي جمعت من مصادر مختلفة وقد برغب عدد قليل من المرضى في الوصول الى النقطة 100% في نهاية المطاف,ولكن هذا يعني ان ما بدأناه كمعتقد إيجابي تحول تدريجيا الى معتقد غير تكيفي (حيث انه من غير المحتمل ان يكون المريض كفؤا دائما في كل ما يقوم به)

ويمكن أن يستخد المتصل كنقطة مرجعيه لمراقبة مدى تقدم المريض فى الاقتناع بالمعتقد الجديد بناءً على المعلومات والأدلة الجديدة التى تم جمعها من خلال سجل المعلومات الايجابية positive date logs وهى عباره عن سجلات لمساعده المريض على جمع المعلومات التى تدعم المعتقد الجديد وتعارض ميله للتركيز فقط على المعلومات التى تؤيد المعتقدات القديمة، أو بلغة أخرى لتصحيح أخطاء معالجة المعلومات، ويتم جمع المعلومات خلال اسبوع أو شهر، حيث يتم جمع المعلومات دون تحيز، وعلى المعالج ان يستخدم تلك السجلات بعد وجود نسبه اقتناع معقولة فى المعتقد الجديد.

5- لعب الادوار العقلانى الانفعالى Rational emotive role playing:

غالبا ما يشتكي المرضى من وجود صراع بين (التفكير العقلي) و (التفكير الانفعالي) ويشير الأول الى اقتناع بسيط بالمعتقد الأساسي الجديد التكيفي (أعلم ان المعتقد الأساسي الجديد عقلاني ومعقول ويساعدني ولكن...) بينما يركز الأخير على اقتناع شديد بالمعتقد الأساسي القديم غير التكيفي (معتقدي القديم يشعرني حقا بحقيقتي) ويشجع لعب الأدوار (العقل,المشاعر) المريض على تعزيز قناعاته في المعتقد الجديد,وإضعاف قناعاته القديمة,ويتم ذلك من خلال محاولة المريض أولا,إقناع نفسه أن معتقده الأساسي القديم (انا غبي) صحيح من خلال حشد جميع الأدلة التي يبدو أنها تدعمه,وثانيا,تحدي هذه الأدلة واحدا تلو الاخر من أجل تقديم تفسيرات أكثر واقعية وتوازنا لنفس الأدلة, وذلك من أجل دعم معتقده الأساسي الجديد (أنا شخص ذكي الى حد معقول). يقول كيهلوين kuehlwein إنه يجب على المريض أن يتحدى الأدلة (بشدة وحزم) و (بمجرد اقتناع المعالج بأن المريض قد استكشف هذا الجانب الثاني بشكل كامل,فإنه يتحقق من انخفاض مستوى الاقتناع بالمعتقد الأساسي القديم والكرب المصاحب له) واذا لم يحدث ذلك يمكن تكرار التدريب.

من غير المحتمل أن يتمكن المريض من إجراء هذا التدريب,دون حث المعالج له على جمع كل الأدلة التي تدعم معتقده القديم (على سبيل المثال تنسى ان أحد أسباب اعتقادك أنك غبي, هو تركك المدرسة بعد الحصول فقط على المؤهل الابتدائي) وللتأكد من ان تحديه لهذه الأدلة مدروس ومتوازن (على سبيل المثال هل تعتقد أنك تقوم بتعريف الذكاء فقط على أساس المؤهلات الاكاديمية

وتتغاضى عن حقيقة أن الذكاء يتضمن مجموعة واسعة من العوامل؟ وعلى سبيل المثال, فأنت ماهر في الاعمال اليدوية,وميكانيكا السيارات, فهل هذه الأشياء علامات على الذكاء؟) وقد يحتاج المعالج في بعض الأحيان الى لعب الأدوار (العقل-المشاعر) قبل ان يقوم المريض بذلك.

مثال اخر على لعب الأدوار (العقل –المشاعر) هو جدال (محامي الشيطان) وفي هذا التكنيك يذكر المريض معتقده الأساسي الجديد (انا شخص ناجح بشكل عام) ومستوى اقتناعه الحالي به (على سبيل المثال 40%) ويحاول المعالج بقوة ان يشكك في قناعات المريض بمعتقده الجديد (على سبيل المثال لقد كان لديك كثير من الإخفاقات أكثر من النجاحات في الآونة الأخيرة,فكيف لك أن تسمي نفسك ناجحا؟) ويتم تشجيع المريض على مواجهة كل حجج المعالج بقوة,والدفاع المستميت عن معتقده الجديد (تعريفي للشخص الناجح يتضمن الإخفاقات,فالتعلم من كل اخفاق هو دليل على النجاح) حتى يصبح المعالج لا يملك أي حجة لكي يقدمها,واذا وجد المريض صعوبة في التعامل مع أي حجة يسوقها المعالج,فسوف نتوقف عن التدريب مؤقتا لمساعدة المريض في العثور على حجة مضادة قوية,ثم يتم استئناف التدريب,وفي نهاية التدريب يعيد المريض تقدير مستوى قناعاته في المعتقد الجديد (على سبيل المثال 60%) واذا ما كان التقدير قد ارتفع بشكل كبير او قليل, او بقى على حاله او انخفض (على سبيل المثال أحد حججك تبدو كالضربة القاضية)وتستكشف أسباب كل نتيجة وتخضع للمناقشة.

6- استمارة المعتقد الجوهرى: صحيفة المعتقد الجوهرى

- المعتقد الجوهرى القديم ..... **- شدة الاعتقاد في المعتقد القديم الان. (صفر – 100%)** **- اشد درجة في الاعتقاد هذا الاسبوع. (صفر – 100%)** **- اقل درجة في الاعتقاد هذا الاسبوع. (صفر – 100%)** **- المعتقد الجديد .....** **- شدة الاعتقاد في المعتقد الجديد الان (صفر – 100%)**	
ادلة تدحض المعتقد القديم وتؤيد المعتقد الجديد	**ادلة تؤيد المعتقد القديم مع اعادة التشكيل**
.....	.....
.....	.....
.....	.....

- درجة الايمان بالمعتقد الجديد الان (صفر – 100%) - درجة الايمان بالمعتقد القديم الان (صفر – 100%)	

7- بطاقات التكيف لمواجهة Coping cards:

وهي غالبا ما تكون في حجم 3×5 سم، حيث يسهل الاحتفاظ بها بالقرب من المريض (في درج المكتب- في الجيب- فى الحقيبة- تعلق علي مرآه الحمام- علي التلاجة)، وبالتالى تسهل قرائتها عده مرات في اليوم (3 مرات علي الاقل)، ويمكن أن تصمم بطاقات التكيف بثلاثة طرق:

أ- الطريقة الاولى: يتم فيها كتابة الافكار غير الواقعية مع كتاب تفنيد واقعي لتلك الافكار.

الفكرة غير الواقعية	الافكار الواقعية او التكيفية او البديلة
- "انا فاشله في تربيه اولادى" - "انا ما انفعش ابقي ام"	"انا من زمان مهتمة باولادي ولبســـهم ونظافتهم، ولو انا فاشـــلة كأن اولادي بقو منحرفين- ودايما يذاكرلهم وبينجحوا، هما بيعملو مشاكل بس دى طبيعة سنهم وكمان سنهم متقارب عشان كده الخلافات بينهم بتبقى كتيرة.

الطريقة الثانية: يتم فيها كتابة بعض الاستراتيجيات التي تساعد المريض علي تخطي المراحل الصعبة مثل مراحل القلق والاكتئاب والغضب والوسواس وغيرها.

عندما اشعر بالاكتئاب والرغبه في الانتحار علي ان اقوم بـ: 1 ممارسه لانشطه السارة 2 تذكر ان الحياه مهما كانت صعبه فان بها اشياء تجبرني ان اعيشها 3 الاتصال باقرب الاصدقاء الي قلبي 4 عدم الجلوس في غرفتي لوحدي

أما الطريقة الثالثة: كتابه ايجابيات المريض أو كلمات المديح الموجه له.

ثانيًا: الاستراتيجيات السلوكية:

1- رصد الانشطه وجدولتها:

تعد انخفاض المدعمات الايجابية من العوامل الاساسية لاستمرار الاكتئاب، لذا تعد تلك المدعمات الايجابية هى الهدف الاساسى للعلاج السلوكى، حيث يعمل العلاج السلوكى على زياده فرص الاستمتاع، من خلال التشجيع على الانخراط الانشطه الممتعة، واعطائه احساس بالانجاز وتحقيق اهداف الحياة.

والخطوة الاولى المبدئية لتحقيق ذلك الهدف هو تقييم انشطة المريض التى اعتاد عليها خلال اليوم، ويتم ذلك أثناء الجلسة على أن يتم استكمال ذلك بين الجلسات من خلال استخدام جدوله الانشطة، أو يطلب من المريض كتابة جميع الانشطة بما فيها تلك الانشطه التى يرون أنها غير مهمة أو تافهة مثل: (الاستحمام- عمل المهام المنزلية- تناول الطعام- مشاهده التلفزيون- الاتصالات التيفونية). وغالبا ما يظهر المرضى مستوى منخفض من الانشطة، وبالتالى مستوى منخفض من الاستمتاع، كما يميل المرضى إلى تذكر الاشياء السلبية فقط، لذا يساعد جدول الانشطة فى التغلب على مثل هذه المشكلات.

والخطوة الثانية أن يطلب من المرضى أن يقيموا مستوى المتعة او الانجاز (0 - 100%) فى كل تلك الانشطة، مما يمدنا بمعلومات حول المدعمات الايجابية التى يمكن إضافتها لأنشطة الحياة اليومية، وبالتالى المساعدة فى عملية التنشيط الانفعالى، فعلى سبيل المثال غسيل الاطباق أو تنظيف المنزل لا تُشعر الاشخاص بالمتعة، ولكنها تسبب الشعور بالانجاز، أما تناول الايس كريم لا يؤدى الى الشعور بالانجاز ولكنه فى الغالب يؤدى احساس المتعة.

والخطوة الثالثة أن يتعاون المعالج والمريض معًا لزيادة كم الانشطة بشكل متدرج، ويمكن الاستعانه بجدول الانشطه المرحة (الممتعة)، بالإضافة إلى الانشطة المتعلقة بالانجاز مثل: (المذاكرة- المهام المنزلية). فغالبًا ما يكون جدول الانشطة الخاص بمرضى الاكتئاب خاليًا من الانشطة ومن الاستمتاع او الانجاز فى بداية العلاج.

جدول الانشطة الاسبوعي

	السبت	الاحد	الاثنين	الثلاثاء	الاربعاء	الخميس	الجمعة
9 - 8 10 - 9 11 - 10 12-11							
1-12							
2-1 3-2 4-3							
5-4							
6-5 7-6 8-7							
9-8							
10-9 11 -10							

2-جدول الانشطة المرحة Pleasurable activities:

وهو عبارة عن قائمة من الانشطة التى يتوقع أن يصاحبها مشاعر الراحة أو السرور، والتى غالبًا ما يفتقدها الاشخاص المصابين بالاكتئاب.

جدول الانشطة المرحة

الانشطة	درجه الاستمتاع المتوقعة	درجه الاستمتاع الحقيقية
ارتداء ملابس افضلها		
اذهب الى حديقة او مصيف		
الاعمال الخيرية (فى المسجد- الكنيسة)		
التحدث عن الرياضة خصوصا كره القدم		
مشاهده أو ممارسة الرياضة		
الذهاب الى المسرح او السنيما او حفلة موسيقية		
التخطيط لأجازه او رحلة		
شراء أشياء		
الصلاه بالمسجد (أو الذهاب الى الكنيسة)		
ترتيب الغرفة او المنزل		
قراءه الصحف او المجلات		
التحدث مع صديقه		
لعب البلياردو		
قياده السيارة		
ركوب الدراجة او الاسكوتر		
مشاهدة التلفزيون		

لعب ألعاب ألكترونية (موبيل- لاب)		
انهاء مهمة صعبة		
حل لغز		
أستكمال الكلمات المتقطعة		
اخذ حمام ساخن		
كتابه القصص او الاشعار		
الغناء		
عزف الموسيقى		
الرقص		
اخذ قيلولة		
الانشطة	**درجه الاستمتاع المتوقعة**	**درجه الاستمتاع الحقيقية**
حل مشكلة شخصية		
وضع مكياج او تصفيف الشعر		
مقابلة اشخاص جدد		
الذهاب الى المعرض او حديقة الحيوان		
التخطيط او تنظيم شئ ما		
الاستماع للراديو او الموسيقى		
تقديم الهدايا		
ألتقاط الصور		
مساعده شخص ما		
سماع نكت		
مشاهده المناظر الطبيعية		
تناول الوجبات اللذيذة		
التمشية فى قلب المدينة		
الذهاب للمتاحف		
الذهاب للجيم		

تعلم شيئ جديد		
قضاء وقت مع العائلة		
التحدث عبر الهاتف		
احلام اليقظة		
الذهاب الى السنيما		
التقبيل		
الطبخ		
تناول وجبات سريعة		
زياره الاصدقاء		
كتابة المذكرات		
الصلاة		
الاسترخاء		
الانشطة	**درجه الاستمتاع المتوقعة**	**درجه الاستمتاع الحقيقية**
عمل حوارات صريحة مع الاصدقاء المقربين		
المشى حافى القدمين		
الذهاب للحفلات		
الذهاب لصالونات التجميل او محلات الحلاقة		
البدء فى مشروع جديد		
مشاهدة الناس فى الطرقات		
اعداد وجبات خاصة جديدة		
بيع و تبادل شيئ ما		
كتابة رسايل لاشخاص مغتربين		
الاعتناء بالنباتات والزهور		
التمشية		
الاعتناء بالاطفال		
اللعب مع الحيوانات الاليفة		

تصفح الانترنت		
الخروج مع الاصدقاء		
ممارسة الرياضة		
اخذ دروس فى الموسيقى او الرقص		

ثالثًا: المهارات الاجتماعية وتوكيد الذات:

تكنيكات توكيد الذات self-assertiveness:

تهدف تلك التكنيكات إلى تعليم المريض توكيد ذاته دون عنف أو عدوان على الاخرين، فبعض المواقف التى يتعرض فيها المريض للإنتقاد من الآخرين أو التصرف بطريقة غير منطقية تجاهه، يحتاج المريض إلى مجموعة من المهارات يمكن أن نسميها أيضاً مهارات الحماية protective skills للمساعدة فى التعامل مع تلك المواقف، من تلك المهارات مايلى:

1- الأسطوانة المشروخة Broken Record: وهنا الشخص يقوم بتكرار رد فعله (لفظياً فى الغالب) مراراً وتكراراً حتى تصل الرسالة للشخص الآخر.

مثال: أن نقول كلمة **"لا"** مراراً وتكراراً دون تفسير لمندوب مبيعات إنتهازى.

ومن أكثر الاخطاء التى يقع فيها الأشخاص أن يقوموا بتقديم تفسيرات لرفضهم، أو يقومون بالإجابة على أسئلة الطرف الآخر، لكن المطلوب هو أن نقول فقط "لا" ببساطة شديدة.

2- التجاهل الإنتقائى selective ignoring:

ويستخدم هذا التكنيك عندما يقوم شخص ما بالتركيز على حدث ما فى الماضى لا يريد المريض أن يتحدث عنه، هنا على المريض أن لا يستجيب للشخص الآخر بالتحدث فى هذا الموضوع: بل يتجاهل هذا الموضوع تماماً

مثال: عندما يستمر شخص ما فى التحدث فى أحداث سابقة لا يريدها المريض، هنا يقوم يقول "احنا تجاوزنا الموضوع ده، وبنتكلم فى موضوع كذا وكذا الآن".

3- تطويق الغضب Disarming anger: ويستخدم هذا التكنيك عندما يتصرف شخص آخر بطريقة عدوانية تجاه المريض، هنا يقوم المريض بتطويق غضب الشخص الاخر من خلال رفصة إستمرار المحادثة حتى يهدأ غضب الشخص الآخر.

مثال: يقول المريض "أنا هتكلم معاك فى أى موضوع إنت عايزه لكن أنا مش هقدر أكلمك وإنت غضبان، إهدأ الأول وبعدين هنتكلم"، وعلى المريض أن يكون مستعداً للإنصات إذا هدأ الشخص الأخر.

4- تصنيف المشكلات sorting Issues: بعض الأشخاص يخلطون القضايا والمشكلات مع بعضها حتى يجبروا المريض أن يتصرف بالطريقة التى يريدونها، وعلى المريض ألا يشتت نفسه بين تلك القضايا أو المشكلات ويركز على المشكلة المهمة مهما كانت الإغراءات .

مثال: شخص يقول لك "مادمت مش عايز تسلفنى يبقى إنت مش بتحبنى ولا مهتم بيا" هنا ينبغى أن يصنف المريض المشكلات ويفصلها عن بعضها فيقول "أنا بالفعل بحبك ومهتم بيك ومش دى المسألة كل المسألة إنى مش عايز أسلفك أو عندى ظروف"، ويمكن أن يستخدم أيضاً طريقة الاسطوانة المشروخة مع طريقة تصنيف القضايا لتحقيق فاعلية أفضل.

5 – عدم الإفراط فى الإعتذار apologies:

كثرة الاعتذار او قول "أنا آسف" تزيد الاحساس بالذنب دون اى داعى، وتجعل المرضى يرون أنهم ليس لهم الحق فى إبداء آرائهم وأفكارهم للآخرين، لذا يتم توجية المريض إلى تجنب الاعتذارات دون سبب وجيه.

ملحوظة1: يمكن أن يطلب من المريض كتابة مميزات توكيد الذات وذلك لزيادة دافعيته .

ملحوظة2: ينبغى أن نوجه المريض ألا يكون قلقًا عند إستخدام تكنيكات توكيد الذات، ونعلمة أن الاخرين سوف يتكيفون بمرور الوقت مع طريقة المريض الجديدة، بل سوف يكونون معجبين بتلك الطريقة، لذا لابد من تعلم تلك المهارات بالتدريج وبحرص شديد حتى لا يشعر المرضى بالتهديد أو بالذنب.

المسار النموذجى للعلاج المعرفى السلوكى للأكتئاب:

توجد مراحل رئيسية ومتقاربة ومتداخلة للعلاج المعرفى، ولكل مرحله منها اهدافها واساليبها العلاجية، ويمكن القول ان المرحله الاولى تتضمن اقامة العلاقة العلاجية والتعليم النفسى، فى حين تستهدف المرحلة التانية التغيرات السلوكية، اما المرحلة الثالثة فهى تهدف الى علاج الافكار التلقائية، والمرحله الرابعة تهدف الى تقيم تعديل المخططات والمعتقدات الجوهرية، أما المرحلة الخامسة والاخيرة فهى تهدف إلى الوقاية من عودة الاعراض مرة اخرى (الانتكاسة)، و فيما يلى تفصيل لتلك المراحل:

المرحلة الاولى: التهيئة للعلاج:

تهدف تلك المرحله الى اقامه علاقه علاجيه تحالفية، قائمة على الاحترام والتقبل والانصات والاستماع، واظهار الود للمريض، كما تتضمن تلك المرحله تعليم المريض تعليمًا نفسيًّا فيما يتعلق باضطراب الاكتئاب وكيفيه التغلب عليه، حيث يقوم المعالج بتقديم معلومات عن الاكتئاب وعن طبيعة أعراضه المرضيه الاكتئابية، والتى تساعد على تطبيع normalize خبراته الاكتئابية، كما قد يعطى معلومات للمريض عن الأدوية (إذا كان ينتظم على الدواء) وخطوات العلاج، وكذلك يقوم باقناع المريض socialization بالنموذج المعرفى البسيط الذى يربط الافكار بالمشاعر والسلوك، وكذلك إعطاء معلومات عن الخطط العلاجية والتى قد تتضمن العوده الى العمل او الدراسة، والاداء الوظيفى والاجتماعى، و تحسن الاعراض الاكتئابيه المزاجية.

- العلاقة العلاجية therapeutic relationship:

توجد العديد من الطرق التى يستطيع بها المعالج المعرفى تقوية العلاقة العلاجية مع المريض من تلك الطرق:

1) ان يتسم موقف المعالج اثناء عملية العلاج بالتعاطف والاحترام، فغالبا ما يتسم مريض الاكتئاب بالاحساس بالفشل والحاجة الى المساعدة، لذا على المعالج ان يظهر الاهتمام بالمريض ومشكلاته، ويظهر التفاؤل بقدره العلاج المعرفى وكفائته فى حل مثل تلك المشكلات.

2) ان يعمل المعالج على ان يكون جو العلاج يسوده الثقة والقبول واحترام الخصوصية، وبالتالى يساعد المريض على البوح بأدق التفاصيل.

3) أن تأخذ اراء المريض فى حل مشكلاته بجديه وباحترام، لان المريض هو الاكثر معرفه بحياته وظروفه و بيئته، كما انه هو المسؤل عن تطبيق تلك الاراء اثناء العلاج.

التعليم النفسى psycheducation:

يعد التعليم النفسى مظهرًا اساسيا فى العلاج المعرفى خصوصا فى الجلسات الاولى منه، ويبدأ التعليم النفسى بعد تعرف المعالج على مشكلات المريض، واهم المواقف المثيره للكرب النفسى فى حياته (خصوصا فى الفتره الاخيرة). ويقوم المعالج من خلال تلك المواقف بتعليم المريض دور طرق التفكير فى نشأه واستمرار و الاعراض الاكتئابيه، ويفضل ان يتم تقديم النموذج المعرفى cognitive model فى صياغته البسيطة (مواقف افكار مشاعر سلوك)، ومع تقدم الجلسات يتم تقديم التصور المعرفى الشامل.

كما يمكن ان يمكن يعرف المريض بأهم الاساليب والتكنيكات التى من المتوقع استخدامها، واستكشاف كيفية تطبيق تلك الاساليب العلاجية، كما يمكن تعريف المريض بمنطق او مبرر استخدام كل تكنيك علاجى، مما يدفع المريض لان يكون اكثر تعاونا.

المرحلة الثانية: التركيز على التغيرات السلوكية:

تهدف تلك المرحله الى إعادة دمج المريض فى بيئته (الاسرة- المدرسة- العمل)، واستعاده الاداء الاجتماعى الطبيعى بأسرع ما يمكن، ومن اهم العلامات الاساسيه التى تحتاج الى تعديلها فى بدايه العلاج (انخفاض الدافعية- وقلة الطاقة والنشاط- والميل للتجنب والعزلة الاجتماعية).

ومن اكثر الاساليب المستخدمة فى تلك المرحلة جدولة الانشطة activity scheduling، وهى تهدف الى مساعدة المعالج على فهم تفاصيل حياه المريض، ونشاطه اليومى، وساعات نومه، ونمط الانشطة ومدتها.

وترجع اهمية استخدام اسلوب جدولة الانشطة إلى أنه يقلل من التحيز الذى يظهره المريض نتيجه لشعوره بالخجل من نمط الانشطة اليومية، كما يقلل من مشكلات الذاكرة او نسيان بعض الانشطة، كما قد يكون جدولة الانشطة فرصة لاختبار توقعات المريض حول الانشطة، مثل توقعاتهم حول قدرتهم على اداء الانشطة وتوقعاتهم حول نتائج تلك الانشطة على المزاج، وعلى المعالج هنا ان يحدد ما اذا كانت تلك التوقعات قائمة على تحيز فى التفكير ام لها أساس واقعى.

وبالاضافة الى التنشيط السلوكى الذى سبق الاشارة اليه من خلال جدولة الانشطة، توجد تكنيكات أخرى تستخدم فى تلك المرحلة مثل حل المشكلات problem solving، ويكون مفيدا حينما تكون المشكله قائمة على اساس واقعى واقل تأثرا بالمعتقدات الجوهرية السلبية، من تلك المشكلات (التكيف فى المدينه الجامعية- التكيف فى بلد اخر- مشكلات خاصه بالزواج وشريك الحياة- مشكلات خاصة بالكلية او الجامعة)، كذلك يمكن ان تستهدف تلك المرحلة بعض المشكلات السلوكية الاخرى، مثل:

1- اختلال النوم sleep disturbance: والذى يمكن التغلب عليه من خلال بعض القواعد (مثل: تغير بعض العادات الخاصه بالنوم- تحديد ساعات للنوم- وعدم النوم نهارًا- عدم استخدام السرير الا للنوم او للعلاقة الجنسية فقط) او التغير فى بيئة النوم (مثل: عدم وجود تليفزيون فى غرفه النوم او اى مشتتات اخرى- ان تكون غرفة النوم هادئة ومظلمة، كذلك يمكن استخدام بعض الاساليب المعرفية والسلوكية الاخرى (مثل الاسترخاء).

2- ضعف الشهية low appetite: ويمكن التغلب عليها من خلال تناول وجبات بشكل منتظم، وعدم تناول المأكولات الخفيفة، وتحسين جودة الطعام.

3- انخفاض الطاقة low energy: ويتم التغلب عليها من خلال الزيادة المتدرجة فى الانشطة العضلية، والتعرف على والتكيف مع ايقاع الجسم اثناء النهار، وأيضا التخطيط لتحسين الطعام.

وينبغى على المعالج فى الثلاث مجالات السابقة (اختلال النوم- ضعف الشهية- انخفاض الطاقة) ان يكتشف المعتقدات السلبية والتوقعات وتعديلها. وتعد تلك المرحلة فرصة لتعليم المريض اداء الواجبات المنزلية بين الجلسات، والتى بدورها تدعم تعلم المهارات وتعطى فرص لتحدى المعتقدات المختلة، كما تعد الواجبات المنزلية مؤشرًا على الدافعية، والامتثال للتعليمات والتقدم فى العلاج.

ملحوظة

اثناء الاكتئاب المتوسط أو الشديد ربما يكون من الصعب ان ينخرط المريض فى اى أنشطة معرفية (تكنيكات معرفية) نتيجة لتأثير الاكتئاب على الطاقه والتركيز والدافعية، كما ان الاشخاص عندما ينخرطون فى سلوكيات (مثل الوحدة او العزلة) يميلون اكثر الى التعمق فى افكارهم الأكتئابية.

المرحلة الثالثة: التركيز على تعديل الافكار التلقائيه السلبية وإعادة البنية المعرفية:

فى تلك المرحلة يتوجه المعالج الى تعديل البنية المعرفية cognitive restructuring، ويتم ذلك من خلال التركيز على التفكير السلبى المرتبط بالمواقف الحياتيه للمريض، وتمر بمرحلتين: الأولى اكتشاف تلك الافكار، والثانية إعادة تقييم تلك الافكار، ويستخدم سجل الافكار المختلة فى الجلسات وأيضًا كجزء من الواجب المنزلى، وفى الجلسة اللاحقه يتأكد المعالج من كفاءه المريض فى استخدام هذا السجل والتعرف على المشكلات اللتى واجهته، و يؤكد من خلاله على النموذج المعرفى. وبمجرد تأكد المعالج من قدره المريض على استخدام سجل الافكار التلقائية بدقه، يتوجه المعالج إلى محاولة تفنيد هذه الافكار، ويتم ذلك من خلال بعض التكنيكات من اهمها: الاسئلة السقراطية والتجارب السلوكية.

ملحوظة1: ليس الهدف العام لتعديل الافكار التلقائيه أن نثبت أنها خاطئة أو غير صحيحة أو سيئة، ولكن لتهيئة عقل المريض إلى احتمالية أن تكون تلك الأفكار خاطئة وأنه يمكن تعديلها، لذا على المعالج ان يأخذ موقفا ان ياخذ موقفًا محايدًا من الادلة التى تؤيد أو تعارض الأفكار التلقائية.

ملحوظة2: احيانا يكون هناك صعوبه فى تحديد مدى صحة وواقعية الافكار خصوصًا فيما يتعلق بنوايا الاخرين تجاه المريض، هنا يمكن استخدام طريقة كشف مميزات وعيوب طريقة التفكير، وفى الغالب تكون المميزات اكثر و ضوحًا، لذا يمكن تشجيع المريض على بذل مجهود اكبر لكشف عيوب تلك الطريقة فى التفكير خصوصًا على المدى البعيد.

المرحلة الرابعة: تعديل المخططات والتعديلات الجوهرية:

يشير النموذج المعرفى الى دور تلك المخططات اوالمعتقدات الجوهرية فى الاستهداف والاكتئاب، وتتسم تلك المعتقدات بأنها عامه وغير مرنة Rigid ومعممة بشكل مفرط، وقبل ان يتم تعديل تلك المعتقدات يقوم المعالج بأستخدام مجموعة من التكنيكات للكشف عن تلك المعتقدات من اهمها تكنيك السهم الهابط ولا يجب استخدام ذلك التكنيك فى بدايه العلاج كما لا يجب استخدامه فى نهايه العلاج، وغالبا ما نبدأ فى تعديل المعتقدات الجوهرية بعد تحسن الاكتئاب الاكلنيكى بشكل ملحوظ.

وبعد ان يتم التعرف على المعتقدات الجوهرية يمكن استكمال الصياغة المعرفية للحالة، فتعديل المعتقدات الجوهرية ليس عنصرًا ضروريًّا فى العلاج المعرفى السلوكى للأكتئاب، فقد تؤدى العلاقة العلاجية القوية (المرحلة الاولى)، والتنشيط السلوكى (المرحلة التانية)، وتعديل الافكار التلقائية (المرحلة الثالثة) إلى تحسن كافى فى المزاج، وتكمن أهمية تلك المرحلة فى منع الانتكاسة، وبعد تعديل الافكار الجوهرية لابد ان يتم استبدالها بمعتقدات بديلة، والعمل على تقوية تلك الافكار تدريجيا من خلال جمع الادلة التى تساندها مع اضعاف المعتقد الجوهرى القديم من خلال اعاده فحص الادلة المؤيدة للاعتقاد القديم.

المرحلة الخامسة: الوقاية من الاكتئاب:

الاكتئاب بطبيعته هو اضطراب يميل إلى العودة مرة أخرى مع مرور الوقت، واحيانًا تكون الأعراض أسوأ فى النوبات اللاحقة، حتى لو تم علاجه بنجاح، وعلى الرغم من ذلك يمكن العمل على منع ظهور تلك الاعراض مرة اخرى، أو حتى التقليل من حدتها عند عودتها، ويتم ذلك مع خلال المراقبة المستمرة للاعراض الاكتئابية (خصوصًا عند بداية حدوثها)، والاستمرار فى المتابعة على فترات متباعدة حتى بعد تحسن الاعراض، وعدم إيقاف الادوية إلا بعد استشارة الطبيب، كذلك التهيئة لعوامل الخطورة او الضغوط المتوقعة فى المستقبل مثل الزواج أو الامتحانات أو غيرها.

خط سير جلسات العلاج المعرفى السلوكى لاكتئاب (حالة حقيقية):

الجلسة الأولى:

- تقييم الاكتئاب وكانت درجته (60) فى الفئة الشديدة.
- التعرف على التاريخ المرضى للحالة.
- تقديم النموذج المعرفى البسيط بصورة عامة.
- إعطاء نبذه سريعة عن طبيعة العلاج والتكنيكات العلاجية والواجبات المنزلية (تعليم نفسى).

الجلسة الثانية:

- تقييم الاكتئاب وكانت درجته (60) فى الفئة الشديدة.
- الاستمرار فى تقديم النموذج المعرفى مع تقديم أمثله خاصة بالمريضة.
- التدريب على ملئ جدول رصد الافكار التلقائية (الأعمدة الثلاث الاولى).

- مساعدة المريض على اختيار الأنشطه السارة من جدول الانشطة السارة.

- التدريب على ملئ جدولة الانشطة (مرحلة الفحص والاستكشاف).

- الواجبات المنزلية (تضمنت رصد الأفكار التلقائية- أداء عدد من الانشطة السارة منها لعب الكوتشينة- بنك الحظ- كوره، بالإضافة إلى عمل عدد من الوجبات المفضلة)- ملئ جدولة الانشطة.

الجلسة الثالثة:

- تقييم الاكتئاب وكانت درجته (52) فى الفئة الشديدة.

- مراجعة الواجبات المنزلية (رصد الأفكار التلقائية- الانشطه السارة- جدولة الأنشطة).

- تدريب المريض بشكل افضل على ملئ جدول رصد الافكار التلقائية.

- ترسيخ فكرة النموذج المعرفى (النصف الاول من الصياغة المعرفية).

- الواجبات المنزلية (تضمنت رصد الافكار التلقائية- الانشطه السارة، وتحديد أهم الانشطة التى سوف يقوم بها المريض منها (المذاكرة- معرفة حسابها فى البنك- توثيق بعض العقود فى الشهر العقارى- الذهاب الى المحامى).

الجلسة الرابعة:

- تقييم الاكتئاب وكانت درجته (55) فى الفئة الشديدة.

- تقديم مجموعة من التشوهات المعرفية (خصوصًا قراءة العقل)، وتعلم كيفية التعرف عليها، وابراز دورها فى نشأه الافكار التلقائية السلبية.

- تقديم الاسئلة السقراطية (خصوصا الادلة والادلة المضادة، ووضع افكار بديلة).

- تعلم ملئ العمودين المتبقين فى جدول سجل الافكار التلقائية مع اعطاء امثله فى الجلسه "كل الناس بتكرهنى".

- الواجب المنزلى (ملئ الاعمده المتبقيه من جدول رصد الافكار لخمسة افكار على الاقل والوصول إلى أفكار بديلة- كشف التشوهات المعرفية فى تلك الافكار- الانشطة المرحة).

الجلسة الخامسة:

- تقييم الاكتئاب وكانت درجته (56) فى الفئة الشديدة.

- مراجعة الواجبات المنزلية، ومناقشة الأفكار البديلة ودرجة الإيمان بها.

- مناقشة اهم مشكلات استخدام الاسئلة السقراطية لملئ جدول رصد الافكار مع تعلم باقى الاسئلة.

- تفنيد (3) أفكار تلقائية أثناء الجلسة، ورصد كيفية تأثير ذلك على المزاج.

- الواجب المنزلى (الاستمرار فى إكمال رصد الافكار التلقائية، وتعديل عدد اكبر من الافكار التلقائية).

الجلسة السادسة:

- تقييم الاكتئاب وكانت درجته (54) فى الفئة الشديدة.

- مراجعة الواجبات المنزلية.

- تفنيد (3) أفكار تلقائية أثناء الجلسة، ورصد كيفية تأثير ذلك على المزاج.

- تحديد تصور مبدئى للمعتقدات الجوهرية.

- الواجب المنزلى (الاستمرار فى إكمال رصد الافكار التلقائية).

الجلسة السابعة:

- تقييم الاكتئاب وكانت درجته (57) فى الفئة الشديدة.

- مراجعة الواجبات المنزلية.

- تفنيد (3) أفكار تلقائية أثناء الجلسة، ورصد كيفية تأثير ذلك على المزاج.

- التدريب على التجارب السلوكيه "لو روحت زورت اخويا مع اولادى هيضايق منى".

- تعلم تدريبات توكيد الذات (خصوصًا الاسطوانة المشروخة)، وتعلم المهارات غير اللفظية لتوكيد الذات.

- الواجبات المنزلية (الاستمرار فى اكمال رصد الافكار التلقائية)، أداء التجربة السلوكية الخاصة بزيارة الاخ، استخدام تكنيكات توكيد الذات مع اقارب الزوج.

الجلسة الثامنة:

- تقييم الاكتئاب وكانت درجته (54) فى الفئة الشديدة.

- مراجعة الواجبات المنزلية.

- تفنيد (3) أفكار تلقائية أثناء الجلسة، مع استخدام طريقة لعب الدور العقلانى الانفعالى، والمتصل المعرفى، ورصد كيفية تأثير ذلك على المزاج.

- استمرار التدريب على توكيد الذات، والمهارات غير اللفظية لتوكيد الذات.

- الواجبات المنزلية (الاستمرار فى اكمال رصد الافكار التلقائية)، ومهارات توكيد الذات غير اللفظية، والانشطة المرحة، واستكمال الدراسة بتجديد عدد ساعات يومى للمذاكرة (جدولة الانشطة).

الجلسة التاسعة:

- تقييم الاكتئاب وكانت درجته (46) فى الفئة المتوسطة.

- مراجعة الواجبات المنزلية خصوصًا عدد ساعات المذاكرة.

- استخدام طريقه السهم الهابط لرصد المعتقدات الوسيطة والجوهرية، وتم رصد مجموعة من تلك المعتقدات، منها: "انا فاشلة- محدش بيحبنى- انا مليش لزمة".

- تقديم الصياغة المعرفيه الكاملة (افتراضيًّا).

- الواجبات المنزلية (استكمال استخدام جدول رصد الافكار التلقائية- الانشطه المرحة، مذاكرة ساعتين يوميًّا).

الجلسة العاشرة.

- تقييم الاكتئاب وكانت درجته (42) فى الفئة المتوسطة.

- مراجعة الواجبات المنزلية.

- تعلم نصف تمرينات الاسترخاء.

- حل بعض المشكلات من خلال اسلوب حل المشكلات مثل: المشكلات القانونية على الشقة.

- الواجبات المنزلية (استكمال جدول رصد الافكار- تكنيكات توكيد الذات- تطبيق ما تم الاتفاق عليه من خلال اسلوب حل المشكلات فيما يتعلق بمعرفه الوضع القانونى للشقه والاتصال بالمحامى).

الجلسة الحادية عشر:

- تقييم الاكتئاب وكانت درجته (36) فى الفئة البسيطة.

- مراجعة الواجبات المنزلية.

- تعلم تمرينات الاسترخاء بشكل كامل.

- حل مشكلة "الشكاوى المتكررة من الابن الاصغر من جانب المدرسة "من خلال اسلوب حل المشكلات".

- اعطاء واجبات منزلية (الاستمرار فى جدول رصد الافكار- التاكد مما تم الاتفاق عليه فى حل المشكلات- ممارسة تمارين الاسترخاء العضلى العميق بشكل كامل- جدولة الانشطة).

الجلسة الثانية عشر:

- تقييم الاكتئاب وكانت درجته (24) فى الفئة الطبيعية.

- مراجعة الواجبات المنزلية.

- حل مشكلة "الشكاوى المتكررة من الابن الاصغر من جانب المدرسة "من خلال اسلوب حل المشكلات".

- اختبار صحة أحد الأفكار الجوهرية "أنا فاشلة" من خلال التعرف على الادلة والادلة المضادة والوصول إلى فكرة بديلة "أنا نجحت فى حاجات كتيرة فى حياتى" بنسبة اعتقاد 25%، ثم استخدام سجل المعتقد الجوهرى للمعتقد الجوهرى القديم والجديد، واستخدام بطاقات التكيف.

- اعطاء واجبات منزلية (تتضمن قراءه بطاقات التكيف يوميًا- والتصرف وفقًا لتلك للمعتقد الجديدة فى الحياه اليومية- كتابة الادلة والأدلة المضادة لفكرتين جوهريتين أخرتين تمهيدًا لاستخدام صحيفة المعتقد الجوهرى، ممارسه تمارين الاسترخاء- جدولة الانشطة).

الجلسة الثالثة عشر:

- تقييم الاكتئاب وكانت درجته (21) فى الفئة الطبيعية.

- مراجعة الواجبات المنزلية.

- استخدام سجل المعتقدات الجوهرية ولعب الدور العقلانى الانفعالى أو المتصل المعرفى لفكرتين جوهريتين.

- الوصول الى افكار بديلة وكتابها على بطاقات تكيف.

- اعطاء واجبات منزلية (تتضمن قراءه بطاقات التكيف يوميًا- التصرف وفقًا لتلك للمعتقدات الجديدة فى الحياه اليومية- كتابة الادلة والأدلة المضادة لفكرتين جوهريتين أخرتين تمهيدًا لاستخدام صحيفة المعتقد الجوهرى- ممارسه تمارين الاسترخاء- جدولة الانشطه).

الجلسة الرابعة عشر:

- تقييم الاكتئاب وكانت درجته (22) فى الفئة الطبيعية.

- مراجعة الواجبات المنزلية

- استخدام سجل المعتقدات الجوهرية ولعب الدور العقلانى الانفعالى أو المتصل المعرفى لفكرتين جوهريتين.

- استخدام بطاقات التكيف مع الافكار البديلة.

- اعطاء واجبات منزلية (يتضمن قراءهة بطاقات التكيف كل مساء- - التصرف وفقًا لتلك للمعتقدات الجديدة فى الحياه اليومية- جدولة الانشطة- الاسترخاء العضلى العميق.

الجلسة الخامسة عشر:

- تقييم الاكتئاب وكانت درجته (20) فى الفئة الطبيعية.

- مراجعة الواجبات المنزليه خصوصًا ما يتعلق بأنعكاس المعتقدات الجديدة البديلة على الحياه اليومية.

- استخدام سجل المعتقدات الجوهرية ولعب الدور العقلانى الانفعالى أو المتصل المعرفى لفكرتين جوهريتين.

- حل مشكلة "مكان شقة الزواج الجديدة وايتعادها عن مدارس الاولاد وأصدقائهم"من خلال اسلوب حل المشكلات".

- بطاقات تكيف للمعتقدات الجديدة.

- اعطاء واجبات منزليه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى حل المشكلات، قراءه بطاقات التكيف- تمارين الاسترخاء- التمهيد لإنها العلاقة العلاجية من خلال تنظيم الجلسات مره كل اسبوعين بدلًا من كل اسبوع.

الجلسة السادسة عشر:

- تقييم الاكتئاب وكانت درجته (20) فى الفئة الطبيعية.

- مراجعة الواجبات المنزلية، خصوصًا ما يتعلق بمكان شقة الزواج.

- تقديم الصياغة المعرفية كاملهة للمريض.

- التعليم النفسى عن العوامل التى تؤدى الى الانتكاسة، وعلامات الانتكاسة وكيفية التعامل مع تلك الأعراض.

- الاتفاق على المتابعة الشهريه ثم المتابعه كل 6 شهور.